

2026 충주 지역정주형 특화산업

모시GO

병원 가는 길, 끝까지 책임집니다

충주 읍·면 어르신들을 위한 AI 합승 통원 배차 플랫폼

투자 단계 Seed 발행일 2026. 07

목차

01

회사 개요

한 줄 정의 · 핵심 투자 포인트

02

문제 & 시장

문제 정의 · Why Now · TAM/SAM/SOM

03

솔루션 & 제품

솔루션 · 핵심 기술 · 경쟁 우위 · 파트너십

04

BM & 성과

수익 모델 · 유닛 이코노믹스 · 실증 · 로드맵

05

팀 & Appendix

팀 구성 · Q&A 백업

회사 소개 — 우리는 무엇을 하는가

ONE-LINE PITCH

모시GO는 충주 읍·면 어르신의 정기 통원을 진료 시간에 맞춘 AI 합승 배차로 왕복 책임지고,
그 과정을
자녀에게 보고하는 지역 모빌리티 플랫폼입니다.

● 해결하는 문제

읍·면 어르신이 이동 수단이 없어
투석·재활 등 정기 치료를 중단·포기한다

● 제공하는 가치

진료 예약 기준 왕복 배차 + 자녀 보고
어르신은 부르지 않고, 자녀는 연차를 안 낸다

● 지금의 단계

3개 채널 프로토타입 완성
북부 3면 파일럿 준비 (차량 2~3대·월 200건)

설립
2026

소재지
충북 충주시

업종
지역 모빌리티 · 헬스케어

투자 단계
Seed

핵심 투자 포인트

01 이동이 무료인데도 치료를 포기하는 시장

충주는 65세 이상에게 버스·콜버스가 월 15회 무료(2025.5~). 그럼에도 읍·면 어르신은 투석을 포기한다. 문제는 가격이 아니라 구조 — 진료 시간을 보장하고 왕복을 책임지는 주체가 없다.

02 합승이 만드는 유일한 지방 원가 구조

1:1 이동은 지방에서 원가가 붕괴한다(8명 태우면 -13.6만). 3인 합승으로 운행당 +4.3만 원 마진. AI 배차는 기술 과시가 아니라 수익모델 그 자체다.

03 예산이 이미 열려 있는 B2G

100원택시(건당 보조), 화천 병원셔틀(조례 운송), 춘천 병원동행(시간당 지원) — 행정 선례가 전국에 있다. 새 예산이 아니라 기존 형식에 엮는다.

04 자산도 인력도 무겁지 않다

차량은 운수사 임차(면허·자산 부담 없음), 동행 인력 없음(관리자 1명이 하루 수십 건) — 확산 시 인건비가 선형으로 늘지 않는다.

충주에서 세 가지 공백이 겹친다

교통 공백

버스로는 진료 시간을 못 맞춘다

- 읍·면 → 거점병원 환승 포함 1시간+
- 배차 간격 1~2시간
- 콜버스는 호출형 — 시간 보장 없음
- 장애인콜택시 법정 25대 중 19대

의료 공백

이동이 안 되면 치료를 포기한다

- 투석 주 3회 · 재활 주 2~3회
- 정기 통원이 생존과 직결
- 매 회차 이동 문제 반복
- → 치료 중단·포기 발생

돌봄 공백

자녀는 수도권에 있다

- 통원일마다 연차 또는 어르신 혼자
- 진료 내용·처방 변경을
- 가족 누구도 모른다
- → 죄책감만 남는다

결국, 충주 읍·면 어르신 약 1.8만 명이 "병원에 갈 수는 있지만 제때 갈 수는 없는" 상태에 놓여 있습니다.

수도권 동행 서비스는 대중교통을 전제로 설계되어 지방에 내려올 수 없다. 충주의 문제는 '동행'이 아니라 이동 × 시간 × 보고의 결합 문제다.

Why Now — 지금이 적기인 이유

수요

초고령사회 진입 완료

충주시 65세 이상 25.2% (2025.8) · 충북 22.7%로 전국 평균(20.8%) 상회 · 인접 괴산군 43.0%

정책

지자체 예산이 열리고 있다

서울 병원안심동행 3년 누적 4.5만 건·만족도 92.9% → 전국 벤치마킹 · 춘천 등 지방 도시도 집행 시작 · 국토부 DRT 가이드라인(2025.12)이 운수사 상생모델 권장

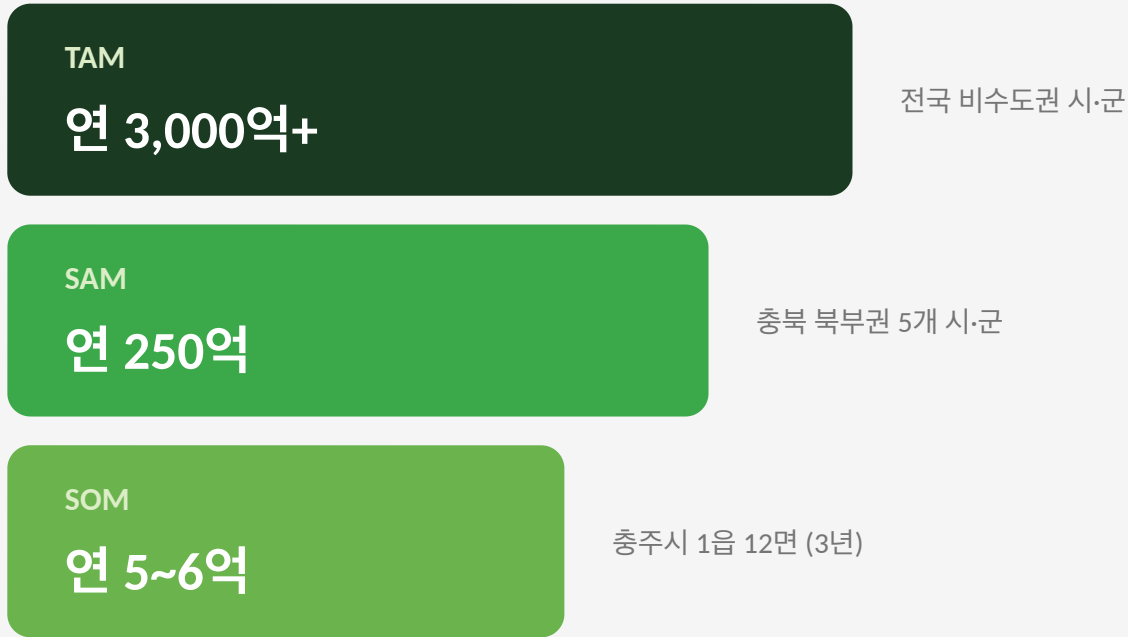
공백

아무도 지방에 없다

위드메이트·케어네이션·케어닥에 수백억 투자 — 전원 대도시·매칭 모델·차량 미포함. 충주 읍·면에는 매칭할 동행인 풀조차 없다

서울에서 시장성이 검증됐고, 지방에는 아무도 없으며, 지자체 예산은 이미 열려 있습니다.
저희는 그 셋이 만나는 지점에 있습니다.

시장 규모 — TAM • SAM • SOM



SOM 이 작아 보일 수 있으나 "지자체 1곳 실증 매출"로는 정직한 숫자입니다. 성장 논리는 "충주에서 검증해 전국 시군으로 복제"입니다.

출처: 행안부 주민등록(2025.8) • 충주시 인구통계(2025.7) • 대한신장학회 등록사업(2024, 인구 10만 명당 157명)

이렇게 해결합니다

01

부르지 않는다, 등록한다

진료 일정을 등록해두면 매 회차 자동 배차.
투석 주 3회 = 캘린더

02

진료 시간에서 역산해 묶는다

AI가 새벽 5시에 시간대(±40분)·방면 클러스터링.
10시 진료 → 09:20 픽업, 문 앞에서 병원 정문까지

03

왕복이 닫히고 자녀에게 전달된다

차량이 병원에 상주 → 진료 종료 후 5분 내 탑승.
탑승·도착·지연·귀가 매 순간 푸시 알림

Before → After

예약

매번 호출

픽업

승강장

시간

도착 유동

귀가

재 호출

가족

정보 없음

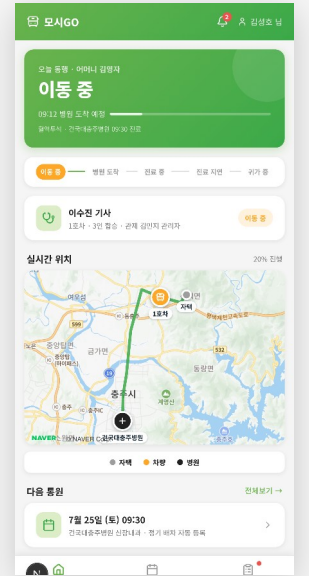
→ 일정 등록

→ 문 앞

→ 역산 보장

→ 병원 상주

→ 푸시+리포트



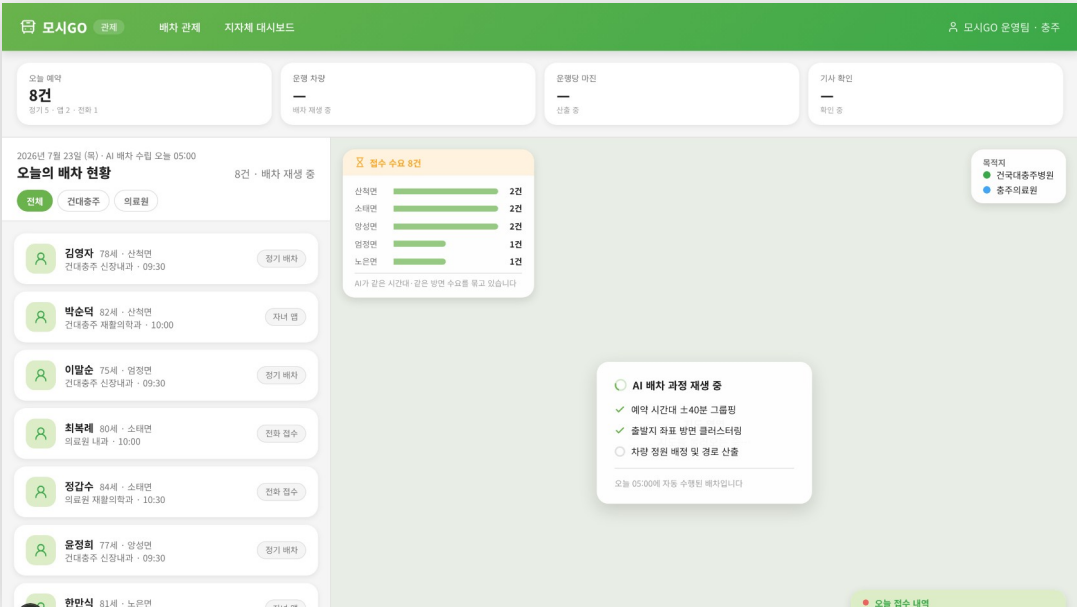
자녀 앱

자녀에게 가는 알림 (통원 1회 4~5건)

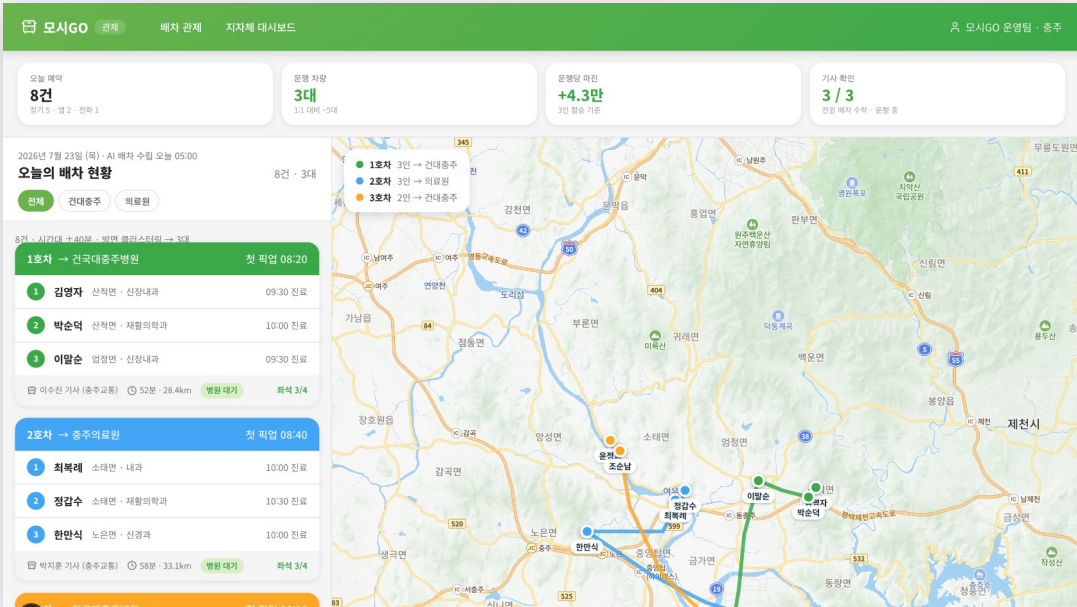
내일 09:20 통원 예정 → 탑승 09:22 → 병원 도착 09:43 → **진료가 길어지고 있습니다 · 차량 대기 중** → 자택 도착 12:40

AI 합승 배차 — 실제 동작 화면

BEFORE · 예약 8건 흩어짐



AFTER · 3개 노선으로 묶임



-62.5%
차량 8대 → 3대

+4.3만 원
운행당 마진

0회
사람이 누른 버튼

새벽 05:00 자동
배차 수립

규칙 기반 최적화(시간대±40분 그룹핑 → 좌표 클러스터링 → 목적지·정원 분할). 운행 데이터가 축적되면 소요시간 예측 모델로 고도화합니다.

핵심 기능 — 모방 난이도

A

AI 합승 배차 엔진 — 수익모델 그 자체

진료 시각 역산 → 시간대(±40분) 클러스터링 → 방면 분할 → 정원 분할.
1:1이면 8대, 합승하면 3대. 초기 규칙 기반 → 데이터 축적 후 예측 모델 고도화

B

왕복 페루프 — 병원 상주 배차

충주 거점병원은 2곳뿐. 오전 등원을 마친 차량이 병원에 상주한다.
목적지가 적다는 지방의 약점을 운영 강점으로 전환

C

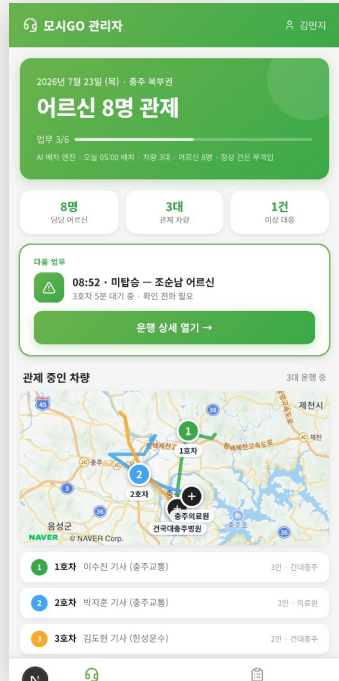
푸시 알림 + AI 통원 리포트

상태 전이마다 자녀 폰으로 자동 푸시. 귀가 후 AI가 리포트 발송.
"앱을 열어야 보이면 조회이고, 폰이 울려야 보고다"

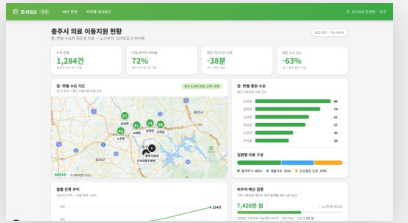
D

케어노트 데이터 자산

휠체어·청력·주의사항이 기사에게 사전 전달되고 회차마다 누적된다.
익명의 호출 기사와 우리를 가르는 것이 이 데이터



관리자 콘솔
사무실에서 운영을 지킨다



지자체 대시보드
B2G 영업 무기

모두
실제 구동
화면입니다

경쟁 구도 & 차별점

	모시GO	충주콜버스	장애인콜택시	민간 동행
이동 제공	○	○	△ 자격제한	X 교통비별도
진료 시간 보장	○	X	△ 예약제	—
왕복 페루프	○	X 편도호출	△	—
보호자 보고(푸시)	○	X	X	△ 예약대행
정기 통원 설계	○	X	X	X 단발
지방 성립	○	○	△ 공급부족	X 공급·가격

○ 제공 △ 제한적 X 제공 안 함 — 해당 없음

충주콜버스 호출형 — 시간 미보장·편도·가족 정보 없음

장애인콜택시 등록 중증장애인 한정 · 대수 부족(19/25)

공공 병원동행 차량 없음(교통비 별도) · 1:1 인건비로 지방 확산 정체

민간 동행 플랫폼 매칭 모델 — 읍·면에 공급자 풀 없음 · 건당 5~10만

결정적 2축

① **의료 특화**
호출이 아니라 진료 예약이 배차 기준이다

② **보호자 채널**
기존 수단 중 가족에게 무언가를 '보내는' 것은 하나도 없다. 푸시 알림이 그 차이를 만든다

소유하지 않고 결합한다

총주시

주 고객

주는 것 · 예산 효율화 + 읍·면별 접근성 지표
받는 것 · 운영 위탁비 / 건당 정산

지역 운수사

이동 공급

주는 것 · 오전 유희 차량에 고정 수요 계약 공급
받는 것 · 차량 임차 (면허·자산 부담 회피)

거점병원

의료 공급

주는 것 · 노쇼 감소 · 재진율 유지
받는 것 · 모객 채널 + 일정 연동 + 주차 협조

읍·면 네트워크

수요 발굴

주는 것 · 지역 어르신 이동 편의
받는 것 · 오프라인 접수 채널 (이장·복지관)

우리가 직접 소유하는 것

· AI 배차 엔진 + 운행 데이터

· 운영 관리자 1~2명

· 케어노트 DB

국토부 DRT 가이드라인(2025.12)이 기존 운수사업자와의 상생협력모델을 권장 — 운수사와 경쟁하지 않는 구조가 정부 방침과 일치

3층 수익 구조 — 판매 단위는 '회차'

1층 · B2G	1년차	총주시	이동지원 예산의 운영 플랫폼	건당 3.5만 원
2층 · B2C	2년차~	타지 자녀	통원권 (구독 / 회수권)	회차 단위
3층 · B2B	2~3년차	거점병원	노쇼 감소 제휴	월 정액

통원권 — 두 갈래

- 정기 통원 구독**

투석·재활 등 고정 스케줄

월 정액 12~13회 · 좌석 우선 · 휴진 이월
- 통원 회수권**

비정기 외래

10회권 · 유효기간 6개월

푸시 알림 · 실시간 위치 · AI 리포트 · 정기 자동배차는 전 이용자 기본 포함

유료 옵션으로 분리하면 "옵션 안 사면 그냥 콜택시"가 되어 차별화 자체가 사라진다 · 지불 흐름: 지자체 바우처 우선 차감 → 초과분만 자녀 결제

1:1이면 적자, 합승이면 흑자

1회 운행 단위 경제 · 3인 합승

수입	바우처 3.5만 × 3인	+105,000
비용	차량 왕복 5.2만 + 운영 1.0만	-62,000

운행당 마진

+43,000원

같은 8명을 태울 때

1:1 배차

차량 8대

-13.6만

AI 합승

차량 3대 (-62.5%)

+9.4만

LTV · 정기 통원 환자 기준

연 150회

주 3회 × 52주

215만 원

연간 기여 마진

3년+

투석 지속 기간

645만 원

LTV

CAC 매우 낮음

병원 투석실에 명단이 이미 모여 있다

위 금액은 공개 통계가 아니라 설계 가정입니다 — 파일럿에서 실제 계약으로 확정합니다

지금까지 한 일 — 숫자로

6개

개발 완료 화면

8→3대

AI 배차 검증 (-62.5%)

6종

분석한 기존 대안

1읍 12면

조사한 행정구역

673건

산출한 월 잠재 수요

12건

확보한 통계 출처

프로토타입으로 증명한 3가지

합승이 원가를 만든다

8대 → 3대, 운행당 +4.3만 전환

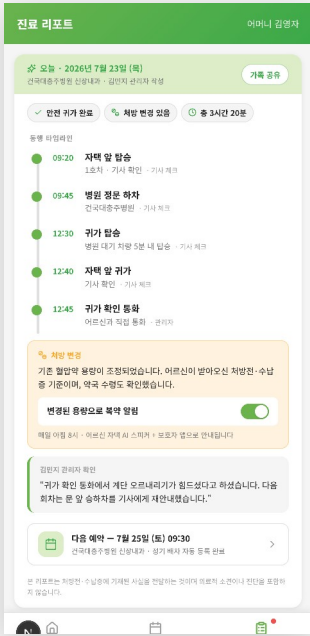
무인 배차가 가능하다

관제 화면에 실행 버튼이 없다

리포트가 자동 생성된다

진료실에 안 들어가도 정보 전달

아직 매출은 없습니다. 대신 "왜 아무도 못 했는지"를 6종 대안 분석으로 규명했고, "우리는 왜 되는지"를 배차 시뮬레이션으로 증명했습니다.



AI 통원 리포트 (실제 화면)

실증 계획 — 앞으로 6개월

파일럿 사양

대상	북부 3면 (산척·엄정·소태)
참여자	1단계 20명 → 6개월 후 50~60명
차량	2~3대 (휠체어 대응 1대 포함)
운행	월 60건 → 월 170~200건
인력	운영 관리자 1명

참여자 구성 · 침투율 25%

	잠재	참여	월 이용	월 건수
투석	11명	3명	주 3회	36건
재활	31명	8명	주 2회	62건
외래	188명	47명	월 1.5회	70건
합계	230명	58명	평균 2.9회	약 170건

검증 KPI — 무엇을 증명할 것인가

90%+	15분 이하	0%	90%+	85%+	+4.3만 실현
정시 도착률	귀가 대기	치료 중단율	재이용률	리포트 만족도	운행당 마진

"기술보다 수요 검증 먼저" — 초기에는 앱 없이 전화 스프레드시트로 시작해 실제 수요를 확인한 뒤 제품화한다

단기 실행 계획 — 무엇을 언제까지

2026.09	충주시 협약	스마트도시과·노인복지과 제안	→ 실증 협약 체결
2026.09	운수사 계약	대일운수·엔씨비 오전 차량 임차	→ 차량 2~3대 확보
2026.10	병원 협조	건국대충주병원 투석실·원무과	→ 환자 안내 + 주차 확보
2026.10	참여자 모집	이장·복지관 + 병원 채널	→ 산책면 중심 20명 등록
2026.11	파일럿 개시	전화·스프레드시트 운영	→ 첫 운행 실시
2027.04	성과 리포트	6개 KPI 측정·정리	→ 충주시 확대 계약 제안

6개월 후 (2027.04)

누적 700건+

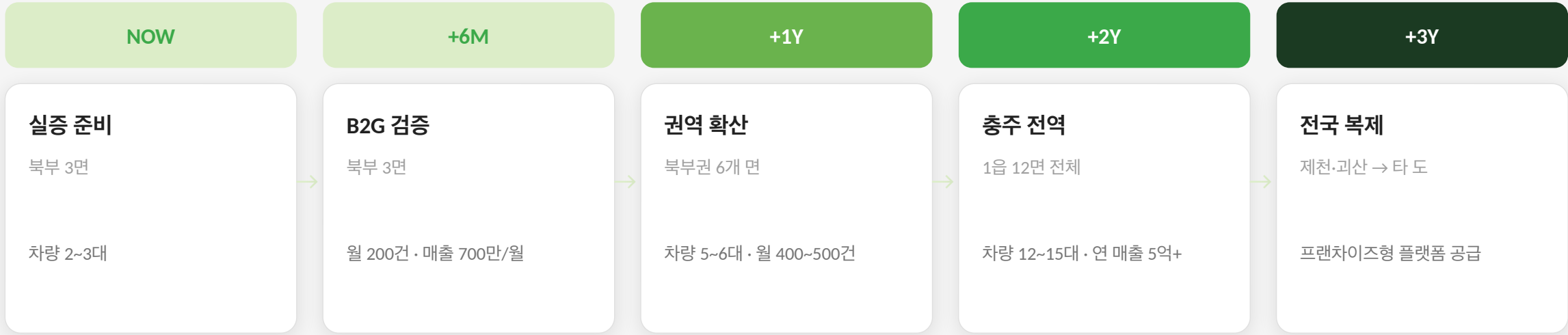
월 200건

이용자 50~60명

월 매출 700만

이 8개 액션으로 "지방에서 통원 배차가 원가와 함께 작동한다"를 증명한다 — 그 데이터가 확대 계약과 병원 제휴를 여는 열쇠다

시장 확장 로드맵



확장 논리 — 왜 순차적으로 열리는가

거점 · Now

충주 북부 3면 — 가장 접근성 나쁜 권역
= 여기서 되면 어디든 된다

인접 · +12~18M

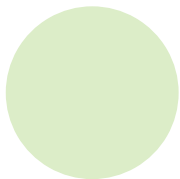
충북 북부권 — 괴산 43.0% · 제천 28.5%
SAM 연 250억

신규 · +24M~

전국 비수도권 군 82개 — 동일한 공백
TAM 연 3,000억+

복제 단위가 가볍다 — 신규 지역 진입에 필요한 것은 운수사 계약+ 관리자 1명+ 지자체 협약뿐이다

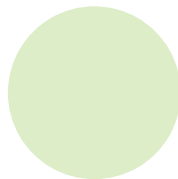
팀 — 우리가 해낼 수 있는 이유



〈이름〉

대표 / CEO

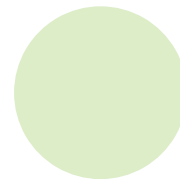
도메인 전문성 · 지역 네트워크



〈이름〉

기술 / CTO

AI 배차 · 플랫폼 개발



〈이름〉

운영 / COO

지역 오퍼레이션 · 복지 행정

가장 강한 카드 — 충주 로컬 네트워크

이장·복지관·거점병원·지역 운수사와의 관계는 자본으로 단기간에 살 수 없는 자산입니다.
대형 플랫폼이 지방에 진입하지 못하는 이유이자, 우리가 이 문제를 풀 책임자인 이유입니다.

충주는 어르신에게 이동이 이미 무료인 도시입니다.

그런데도 투석을 포기합니다.

저희가 파는 것은 이동이 아니라, 약속을 지키는 운영 체계입니다.

모시GO

병원 가는 길, 끝까지 책임집니다